Francescapp

Diário integrado do cuidado

Proposta de negócio para Edilaine Francescato

Versão 0.1 | 6 de outubro de 2026 | Para discussão e validação

Um espaço para reunir o que acontece com a pessoa acompanhada, conectar equipe e família e manter claros os objetivos, os compromissos e os próximos passos.

A necessidade

Hoje, registros, anamneses e informações do acompanhamento precisam ser centralizados. Para quem coordena o caso, ter documentos guardados é apenas parte da resposta: também é necessário saber o que mudou, o que pede atenção e quem deve agir.

A proposta

Cada caso terá um diário por texto ou áudio transcrito, uma linha do tempo, um resumo revisado, um plano de cuidado, tarefas e agenda. A família poderá registrar acontecimentos e anexar imagens; os profissionais compartilharão sínteses úteis à coordenação, preservando o conteúdo que exige sigilo.

O que orienta o projeto

O posicionamento público da Francescato destaca autonomia, relações familiares e acompanhamento fora do consultório. A proposta organiza informações para apoiar essa atuação, incluindo rotina, barreiras ao cuidado e continuidade entre profissionais. Referência: Case Management da Francescato.

O ganho esperado: Edilaine abre o caso, entende a situação atual, identifica uma pendência e encontra quem ficou responsável pelo próximo passo.

Este documento propõe escopo e experiência de uso. Público, prioridades e regras serão validados com Edilaine. Arquitetura, implementação, orçamento e cronograma serão discutidos em outra etapa.

Quem participa e como o cuidado se conecta

Participantes

Pessoa	Principal necessidade
Edilaine / case manager	Coordenar o acompanhamento e enxergar mudanças, prioridades e pendências
Profissionais da equipe	Registrar sínteses curtas e consultar informações necessárias à sua atuação
Família e cuidadores	Relatar acontecimentos e encontrar agenda, orientações e retorno
Pessoa acompanhada	Ter preferências e objetivos respeitados e participar conforme o acordo de cuidado
Apoio administrativo	Organizar logística com acesso aos dados operacionais necessários

O paciente, o responsável legal, o cuidador e quem paga podem ser pessoas diferentes. O vínculo de cada um precisa ficar claro, sem conceder acesso automaticamente por parentesco ou pagamento.

Um exemplo de uso

Exemplo fictício, sem dados de pacientes reais:

1. Um cuidador registra por áudio que houve dificuldade para manter a rotina e informa o que aconteceu antes e depois.
2. O texto transcrito aparece como rascunho; o cuidador corrige, confere o caso e a audiência e publica.
3. Edilaine consulta o relato, registra um retorno e atribui uma ação a um profissional autorizado.
4. O profissional compartilha a síntese relevante do atendimento e o próximo passo, sem expor conteúdo privado da sessão.
5. A equipe revisa o objetivo de rotina e ajusta os combinados, preservando a versão anterior do plano.
6. Na próxima revisão, Edilaine encontra a sequência dos acontecimentos e consegue acompanhar o que foi feito.

A informação termina em ação: relato, revisão, responsável e acompanhamento ficam relacionados. “Enviado”, “consultado” e “retorno registrado” são situações diferentes.

Diário e modelos de preenchimento

Registro simples, com contexto

O participante escolhe o caso, informa quando aconteceu e descreve o acontecimento. Contexto, ação tomada, pedido de retorno e anexo são opcionais no relato simples. O objetivo é permitir registro pelo celular sem exigir um formulário longo a cada entrada.

Categorias sugeridas: rotina e autocuidado, sono, alimentação, atividade, convivência, dificuldade, conquista, acontecimento importante e outro. São categorias de relato, sem pedir que a família faça diagnóstico.

Áudio que facilita o registro

O autor dita o próprio relato. A transcrição vira um rascunho editável, com possibilidade de ouvir o original, corrigir nomes e trechos incertos e conferir quem poderá ler. A publicação sempre depende de revisão humana. Texto continua disponível quando não for possível gravar ou transcrever.

Gravação de sessões completas não faz parte da proposta inicial. Finalidade e guarda do áudio original serão definidas antes do uso real.

Formulários que ajudam, sem duplicar trabalho

Modelo	Seções propostas
Entrada / anamnese de coordenação	Prioridades, rotina, rede familiar, saúde informada, recursos, barreiras, preferências, documentos e próximos passos
Acontecimento familiar	Quando, descrição, contexto, ação tomada, retorno desejado e anexo
Síntese profissional	Atividade, observações compartilháveis, progresso, orientação e próximo passo
Registro de coordenação	Contato ou ação, participantes, combinado, pendência, responsável e prazo
Revisão do plano	Objetivos, progresso, fontes, barreiras, perspectiva do paciente e próximas ações

Os profissionais validarão os modelos da própria área. Informação ainda desconhecida poderá ficar pendente. Relato familiar, hipótese profissional e diagnóstico documentado manterão suas fontes identificadas.

Visão do caso e coordenação do cuidado

Resumo atual e linha do tempo

O resumo reúne situação atual, objetivos ativos, mudanças recentes, pendências, compromissos e próxima revisão. Mostra quem revisou e quando; novos registros ainda não incorporados ficam sinalizados.

A linha do tempo reúne acontecimentos e ações autorizados, com filtros por período, tipo, autor e área. Data do acontecimento e data do registro ficam distintas. Correções preservam motivo e autoria; relatos divergentes continuam identificados por fonte.

Plano simples e verificável

Cada objetivo terá responsável, situação inicial, forma de acompanhar progresso e data de revisão. A equipe poderá indicar em andamento, atingido, pausado, revisar ou encerrado. O plano incluirá o que a pessoa deseja recuperar, seus pontos fortes e as barreiras encontradas.

Uma recomendação pode gerar uma tarefa ou encaminhamento com responsável e prazo. Quando a ação for concluída, o resultado fica registrado. Usar a expressão PTS dependerá da prática validada da equipe.

Agenda do paciente

Atendimentos e outros compromissos aparecem em uma visão consolidada, com recorrência, local ou modalidade e participantes autorizados. A equipe registra realizado, falta, cancelamento ou remarcação. Um horário passado sem confirmação fica como “realização não confirmada”.

Motivos de ausência ajudam a identificar dificuldades de transporte, custo, rotina ou disponibilidade, evitando transformar toda falta em um rótulo clínico.

Carteira da case manager

Edilaine vê casos com revisão próxima, tarefas vencidas, retorno pendente e atualizações esperadas. Cada sinal mostra o motivo e o responsável. Ausência de informação aparece como “informação insuficiente”.

Sinal operacional não é avaliação clínica: estar em dia com agenda e registros não significa ausência de risco. Atenção clínica será sinalizada e acompanhada por profissional habilitado.

Compartilhamento com limites claros

Centralizar as informações necessárias ao cuidado exige distinguir o que pode ser compartilhado, com quem e para qual finalidade. Todo autor confere a audiência antes de publicar.

Participante	Acesso proposto	Limite
Case manager	Síntese e informações necessárias aos casos atribuídos	Sem acesso automático a conteúdo terapêutico restrito
Profissional da equipe	Informações autorizadas relevantes à sua atuação	Sem acesso geral a outros casos ou registros privados de colegas
Familiar / cuidador	Próprios relatos e conteúdo expressamente disponibilizado	Sem acesso padrão aos relatos de outros familiares ou à discussão interna
Paciente, quando habilitado	Registros próprios e conteúdo disponibilizado; fluxo de acesso aos seus dados	Participação ajustada à idade, representação e acompanhamento
Administrativo / financeiro	Dados de logística ou despesas que lhe forem atribuídos	Função administrativa e pagamento não liberam dados de saúde

Como isso se aplica na primeira versão

O diário familiar será dirigido à coordenação e ao próprio autor. Compartilhar com outro familiar ou com a equipe dependerá da audiência definida. O núcleo profissional contém sínteses compartilháveis; migrar notas clínicas privadas detalhadas exige validação específica.

A saída de um profissional revoga seu acesso e preserva sua autoria histórica. Um substituto temporário de Edilaine recebe somente os casos e o período autorizados. Casos de pessoas da mesma família continuam separados.

Restrições no portal não eliminam direitos de acesso da pessoa atendida. Solicitações serão tratadas pelo procedimento adequado, considerando também terceiros e regras profissionais. A orientação do CRP-16 reforça o compartilhamento do necessário em contexto multiprofissional e a proteção do material restrito.

Proteção, documentos e situações de atenção

Controle institucional dos arquivos

Anexos serão organizados por caso, categoria, origem, data e versão. A proposta contempla Google Drive e OneDrive em espaço administrado pela Francescato. Para o piloto, recomenda-se escolher o provedor já utilizado institucionalmente; a segunda opção pode entrar depois.

As permissões precisam valer também para os arquivos, sem links públicos ou compartilhamento incompatível. Se um arquivo for removido ou o espaço conectado estiver indisponível, o sistema mostrará a situação e a ação necessária.

A Francescato deve conseguir exportar o histórico autorizado e recuperar seus documentos ao encerrar o uso do produto. Isso preserva continuidade operacional, sem confundir administração dos arquivos com titularidade dos dados pessoais.

Proteção desde o primeiro caso

Dados de saúde exigem tratamento específico. Consentimento não é a única base possível; finalidades e responsabilidades precisam ser avaliadas. Guarda e solicitações de exclusão também dependem do contexto e de obrigações aplicáveis. Referências: ANPD e LGPD.

O requisito proposto é proteção verificável de todos os dados identificáveis: textos, áudios, imagens, documentos e cópias de recuperação. Proteger apenas nome e documento pessoal é insuficiente. A operação deve registrar consultas, mudanças de acesso, alterações e exportações.

Plano de crise e retorno

O caso terá orientações previamente aprovadas por profissional habilitado, contatos, responsáveis e limites de funcionamento. Um registro marcado como importante não garante resposta imediata. Envio ou leitura não significam avaliação clínica concluída.

O sistema apoia a coordenação; diagnóstico, prescrição e conduta permanecem sob responsabilidade profissional. Para crianças e adolescentes, audiências e participação devem observar o melhor interesse, conforme orientação da ANPD.

Prioridades e como avaliar o resultado

Primeira versão sugerida

Cadastro e anamnese de coordenação; vínculos e permissões; diário por texto e áudio transcrito; imagens e documentos; linha do tempo e resumo revisado; plano simples; tarefas e encaminhamentos; agenda; carteira com pendências; orientações e plano de crise. Auditoria, proteção e exportação fazem parte desse núcleo.

Evoluções após validar o uso

Reuniões e passagem de acompanhamento; acesso direto do paciente, se não for antecipado; contribuição limitada de profissionais externos; medidas de progresso; segundo provedor de arquivos; avisos mínimos via WhatsApp; prestação de contas de despesas do cuidado.

Assistência automática poderá rascunhar resumo, pauta e devolutiva com fontes autorizadas e revisão humana. Não fará diagnóstico nem previsão de risco clínico. A transcrição revisada de relatos já integra a primeira versão.

Piloto proposto

Começar com demonstrações de casos fictícios. Depois das validações de negócio e proteção, acompanhar três a cinco casos por quatro semanas, com profissionais de ao menos duas áreas e familiares voluntários. Quantidade e duração serão ajustadas com Edilaine.

Resultado esperado	Meta proposta
Registrar sem esforço excessivo	Pelo menos 80% dos participantes de cada grupo concluem relato simples pelo celular em até 2 minutos
Compreender o caso rapidamente	Em 90% dos exercícios, identificar situação, mudança, pendência e próximo responsável em até 3 minutos
Manter registros úteis	Pelo menos 85% das sínteses combinadas são publicadas no prazo acordado durante o piloto
Reduzir busca e cobranças	Redução de 30% do tempo semanal da case manager, comparada à rotina atual e ao volume de casos
Preservar compartilhamento	Nenhuma exposição indevida nos exercícios definidos de acesso antes de usar dados reais

As metas são hipóteses para validação. Não se atribuirá ao sistema promessa de redução de internações ou resultado clínico.

Decisões para a conversa com Edilaine

Confirmar antes de fechar o escopo

1. Quais são o público predominante, as idades e os tipos de acompanhamento? Quais três situações recentes deram mais trabalho por falta de informação?
2. Quem registra hoje, quem precisa consultar e o que deve ficar restrito? Como diferenciar paciente, cuidador, responsável legal e pessoa que paga?
3. O próprio paciente deve participar desde o início? Quais preferências e objetivos ele deve acompanhar?
4. Quais formulários e registros já funcionam? O que pode ser reaproveitado para evitar preenchimento duplicado?
5. Em quais horários a equipe responde, quem substitui Edilaine e qual é o fluxo aprovado para situações de crise?
6. Drive ou OneDrive já é utilizado pela Francescato? Quem administra os documentos, as permissões e a continuidade?
7. Prestação de contas de despesas precisa entrar na primeira versão? Quantos casos e participantes devem estar no piloto?

Identidade visual de referência

O site observado no Chrome usa verde oliva **#879257**, verde claro **#AEBA7B**, areia **#E3CCB0**, marrom **#6F604B** e branco. A tipografia combina Raleway e um destaque serifado em itálico. A referência será adaptada para leitura confortável, contraste e estados com significado claro. Fonte: Francescato Family.

O que precisa sair da reunião

Uma lista de prioridades para o núcleo inicial, participantes do piloto, modelos de registro e regras de acesso e retorno. As definições de guarda, fundamento de tratamento e responsabilidade profissional precisam estar validadas antes de usar dados reais.

A proposta parte da Francescato como operação inicial, com equipe e familiares autorizados. Essas são hipóteses de trabalho, abertas à revisão. O nome Francescapp também é provisório.

Próximo passo: revisar o escopo com Edilaine e incorporar suas decisões na especificação de negócio.

Referência complementar de gestão de casos: CMSA. Requisitos detalhados, jornadas e condições de aceite estão na especificação completa do projeto, versão 0.1.